Клинические рекомендации

Острый тонзиллит и фарингит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J02** — Острый фарингит **J02.0** — Стрептококковый фарингит **J02.8** — Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями **J02.9** — Острый фарингит неуточненный **J03** — Острый тонзиллит [ангина] **J03.0** — Стрептококковый тонзиллит **J03.8** — Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями **J03.9** — Острый тонзиллит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 31.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/306_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Клиническая картина 3

2.3 Чувствительность возбудителя и колонизация 4

2.4 Дифференциальная диагностика 4

3. Диагностика 4

3.1 Исследования, не показанные рутинно 5

3.2 Шкала Центора в модификации МакАйзека 5

3.3 Шкала FeverPAIN 6

4. Лечение 6

4.1 Антибактериальная терапия 6

4.2 Дозы для приёма внутрь 7

4.3 Парентеральная терапия 8

4.4 Симптоматическая терапия 8

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации. Осложнения 9

6. Источник и актуальность **9**

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 10

1. Основные положения

- Возбудителями тонзиллофарингита в большинстве случаев являются вирусы, и антибактериальная терапия при этом не показана. Из бактериальных возбудителей лечения требует только бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА); выделение из зева стафилококка, пневмококка и других микроорганизмов расценивается как колонизация.
- По клинической картине дифференцировать вирусный и бактериальный тонзиллофарингит невозможно. Пациентам старше 3 лет показан экспресс-тест на БГСА; при отрицательном результате у ребёнка показано подтверждение бактериологическим исследованием (посевом).
- Антибактериальная терапия назначается только при доказанной или высоковероятной стрептококковой этиологии. При вирусной инфекции антибиотики неэффективны и не предотвращают присоединения бактериальной инфекции.
- Препаратом выбора является амоксициллин, курс лечения составляет 10 дней.
- При отсутствии улучшения через 48–72 часа от начала антибактериальной терапии следует пересмотреть диагноз, поскольку заболевание может быть обусловлено острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) или инфекционным мононуклеозом.
- Рутинное определение С-реактивного белка (СРБ) и прокальцитонина, общий анализ крови в амбулаторных условиях, исследование антистрептолизина О (АСЛ-О) и контрольный мазок после лечения не показаны.

2. Клиническая картина и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определение

Острый тонзиллофарингит является острым инфекционным воспалением слизистой оболочки и лимфоидной ткани ротоглотки (нёбных миндалин и лимфоидных фолликулов задней стенки глотки). Термин объединяет острый тонзиллит и острый фарингит, поскольку чаще в воспалительный процесс вовлекаются оба отдела.

По локализации в зависимости от преимущественно поражённого отдела ротоглотки различают тонзиллит, фарингит и тонзиллофарингит. По этиологии выделяют стрептококковый и нестрептококковый (вирусный) тонзиллофарингит. Тактика лечения определяется именно этиологией.

2.2 Клиническая картина

Заболевание начинается остро, как правило, с повышения температуры тела выше 38 °C (реже температура нормальная или субфебрильная) и боли в горле, которая усиливается при глотании и может иррадиировать в ухо. Регионарные лимфатические узлы могут быть увеличены и болезненны, дети младшего возраста отказываются от еды. Состояние удовлетворительное или средней тяжести.

О стрептококковой этиологии свидетельствуют увеличение подчелюстных или переднешейных лимфатических узлов, высокая температура тела, выраженная боль в горле, «пылающий зев», налёт на миндалинах, отсутствие насморка, кашля и конъюнктивита.

На вирусную этиологию указывают насморк, конъюнктивит и кашель. При инфекции, вызванной вирусом Эпштейна — Барр, возможны генерализованная лимфаденопатия, увеличение печени и селезёнки. Петехии на мягком нёбе встречаются как при стрептококковой инфекции, так и при инфекции вирусом Эпштейна — Барр.

При тонзиллофарингите отмечается симметричное увеличение миндалин, что отличает его от паратонзиллярного абсцесса.

2.3 Чувствительность возбудителя и колонизация

Все штаммы БГСА чувствительны к пенициллину и всем бета-лактамам. Устойчивость к макролидам выявляется примерно у каждого пятого штамма, к клиндамицину у 3–4%.

Выделение из зева *S. aureus*, *S. pneumoniae* или других бактерий при клинической картине тонзиллофарингита расценивается как колонизация и не требует назначения антибиотиков.

2.4 Дифференциальная диагностика

Инфекционным мононуклеозом чаще болеют подростки и лица молодого возраста до 30 лет. Характерны слабость, лимфаденопатия, увеличение печени и селезёнки, атипичные мононуклеары в периферической крови. Диагноз подтверждается методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на ДНК вируса Эпштейна — Барр и выявлением IgM к капсидному антигену.

Синдромом «рука — нога — рот» болеют дети до 5 лет, как правило в летний период: на слизистой оболочке полости рта появляются везикулы без налётов на миндалинах, на кистях и стопах отмечается сыпь.

При ангине Симановского — Плаута — Венсана на одной миндалине формируется некротическая язва, отмечается гнилостный запах.

При дифтерии зева налёт плотный, снимается с трудом, после снятия остаётся кровоточащая поверхность.

Синдром Маршалла (PFAPA) характеризуется периодической лихорадкой до 39–40 °C в сочетании с тонзиллитом или фарингитом, афтозным стоматитом и шейным лимфаденитом. Приступы повторяются каждые 1–2 месяца, средний возраст детей составляет 5 лет; приступ быстро купируется системными кортикостероидами.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР
Диагноз устанавливается на основании жалоб на выраженную боль в горле при глотании, данных осмотра (гиперемия, инфильтрация и отёк миндалин, увеличение регионарных лимфатических узлов) и результатов экспресс-теста на БГСА или бактериологического исследования.

Каждому пациенту показан осмотр оториноларингологом, педиатром, врачом общей практики или терапевтом.

У каждого пациента необходимо проводить дифференциальную диагностику стрептококкового и вирусного тонзиллофарингита.

Экспресс-тест на БГСА проводится пациентам старше 3 лет. При положительном результате посев не требуется. При отрицательном результате у взрослых посев также не требуется, у детей и подростков результат подтверждается бактериологическим исследованием.

Детям до 3 лет экспресс-тест рутинно не проводится; исключением является стрептококковый тонзиллит у кого-либо из окружения ребёнка, например у старшего брата или сестры.

Бактериологическое исследование мазка из зева на стрептококк группы А показано пациентам старше 3 лет, если экспресс-тест не проводился или его результат отрицательный. Результат готов в течение 72 часов.

Мазок берётся до начала антибактериальной терапии, до утренней гигиены полости рта, натощак или через 2 часа после еды, под контролем орофарингоскопии, без касания зубов и языка, из устьев крипт миндалин и с задней стенки глотки.

3.1 Исследования, не показанные рутинно

В амбулаторных условиях определение СРБ и прокальцитонина не позволяет дифференцировать вирусное и бактериальное воспаление. СРБ определяется при госпитализации, прокальцитонин у пациентов в тяжёлом состоянии в стационаре.

Общий анализ крови в амбулаторных условиях выполняется только по показаниям, например для исключения инфекционного мононуклеоза.

Исследование АСЛ-О применимо только для ретроспективной диагностики, поскольку его уровень повышается лишь на 7–9-й день. Исследование проводится при подозрении на ревматическую лихорадку, гломерулонефрит или детские аутоиммунные нейропсихиатрические расстройства, ассоциированные со стрептококковой инфекцией (PANDAS).

Контрольный мазок на БГСА после лечения не показан, если пациент не относится к группе высокого риска ревматической лихорадки и симптомы не рецидивируют.

У детей старше 3 лет следует обращать внимание на насморк, кашель, охриплость и конъюнктивит: при стрептококковой инфекции эти симптомы встречаются не более чем у 10% пациентов и только при сопутствующей вирусной инфекции.

3.2 Шкала Центора в модификации МакАйзека

Признак	Баллы
Температура тела выше 38 °C	1
Отёчность и гиперемия миндалин, налёты на задней стенке глотки и миндалинах	1
Отсутствие катаральных явлений и кашля	1
Переднешейный и/или подчелюстной лимфаденит	1
Возраст 5–14 лет / 15–44 года / 45 лет и старше	1 / 0 / −1

Баллы	Вероятность БГСА: ≥15 лет / 3–14 лет	Тактика
0–1	7–12% / 8–14%	Посев и/или антибактериальная терапия не показаны
2–3	21–38% / 23–37%	Антибактериальная терапия по результатам экспресс-теста и/или посева
4 и более	57% / 55%	Антибактериальная терапия на основании клинической картины

3.3 Шкала FeverPAIN

По одному баллу начисляется за каждый признак: повышение температуры тела за последние сутки, налёт на миндалинах, обращение в первые 3 дня в связи с выраженными симптомами, выраженные гиперемия и отёк миндалин, отсутствие кашля и насморка.

Вероятность стрептококковой инфекции групп A, C или G составляет 16% при 0–2 баллах, 43% при 3 баллах, 63% при 4–5 баллах.

Шкалы позволяют выявить пациентов с высокой вероятностью стрептококковой инфекции, однако не дают возможности установить диагноз с абсолютной точностью.

---

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Антибактериальная терапия

При вирусной инфекции системные антибактериальные препараты не назначаются: они неэффективны и не предотвращают присоединения бактериальной инфекции.

Профилактическое назначение антибиотиков при вирусном тонзиллофарингите не рекомендуется.

Антибактериальная терапия назначается только при доказанной или высоковероятной стрептококковой этиологии.

При стрептококковом тонзиллите препаратом выбора является амоксициллин.

При инфекционном мононуклеозе на фоне приёма амоксициллина возможно появление сыпи, однако она возникает и при приёме других антибиотиков, и без них, поэтому при мононуклеозе следует избегать назначения любых системных антибактериальных препаратов.

Пенициллины, цефалоспорины, линкозамиды и макролиды, за исключением азитромицина, назначаются курсом 10 дней.

При рецидивирующем стрептококковом тонзиллофарингите назначается амоксициллин с клавулановой кислотой или клиндамицин (детям старше 3 лет) курсом 10 дней. Показана консультация оториноларинголога для исключения хронического тонзиллита, у детей также синдрома PFAPA.

Если через 48–72 часа от начала антибактериальной терапии температура тела и боль в горле не уменьшились, следует пересмотреть диагноз: наиболее вероятны ОРВИ или инфекционный мононуклеоз.

При нетяжёлой аллергии на пенициллины назначаются цефалоспорины II–III поколения: цефуроксим, цефиксим, цефдиторен или цефподоксим. Перекрёстная аллергия с пенициллинами встречается менее чем в 2% случаев для цефалоспоринов II поколения и менее чем в 1% для III поколения.

Уровни доказательности для этих препаратов в рекомендации различаются: для цефуроксима УУР C, УДД 5; для цефиксима C и 5 у детей, B и 1 у взрослых; для цефдиторена C и 2; для цефподоксима B и 2. Курс лечения составляет 10 дней.

При аллергии на цефалоспорины или тяжёлой реакции на бета-лактамы (анафилактический шок, отёк гортани, тяжёлая крапивница) назначаются макролиды или линкозамиды с учётом возможной устойчивости стрептококка к макролидам.

Бензатина бензилпенициллин вводится однократно внутримышечно вместо курса пероральной терапии только при сомнениях в том, что пациент будет принимать препарат. Доза для детей с массой тела до 27 кг составляет 600 тысяч ЕД, более 27 кг 1,2 миллиона ЕД.

4.2 Дозы для приёма внутрь

Препарат	Взрослые	Дети
Стартовая терапия, 10 дней		
Амоксициллин[1]	1,5 г/сут в 3 приёма или 1,0 г/сут в 2 приёма	50 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Альтернатива		
Бензатина бензилпенициллин[2] **в/м, однократно**	2,4 млн ЕД	менее 27 кг — 600 тыс. ЕД; более 27 кг — 1,2 млн ЕД
Цефалексин	старше 10 лет: 500–1000 мг/сут в 2 приёма	3–10 лет, только таблетки: 25–50 мг/кг/сут в 4 приёма, не более 1000 мг/сут
Рецидив и/или неэффективность амоксициллина		
Амоксициллин + клавулановая кислота[1] [3] **(во время еды)**	1750 мг/сут по амоксициллину в 2 приёма	50 мг/кг/сут по амоксициллину в 2–3 приёма
Нетяжёлая аллергия на пенициллины		
Цефуроксим (сразу после еды)	1,0 г/сут в 2 приёма	20 мг/кг/сут в 2 приёма
Цефиксим	400 мг/сут в 1–2 приёма	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен (после еды)	400 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 400 мг/сут в 2 приёма
Цефподоксим (во время еды)	200 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 200 мг/сут в 2 приёма
Аллергия на цефалоспорины и/или тяжёлая реакция на пенициллины		
Кларитромицин	500–1000 мг/сут в 2 приёма	15 мг/кг/сут в 2 приёма
Джозамицин (между едой)	1,0 г/сут в 2 приёма	40–50 мг/кг/сут в 2 приёма
Азитромицин (за 1 час до еды)	500 мг/сут в 1 приём, **3 дня**	20 мг/кг/сут в 1 приём, 3 дня
Мидекамицин (за 1 час до еды)	1,2 г/сут в 3 приёма	старше 3 лет: 50 мг/кг/сут в 2 приёма
Спирамицин	6 млн МЕ/сут в 2 приёма	старше 6 лет, более 20 кг: 300 тыс. МЕ/кг/сут в 2 приёма
Клиндамицин (запивать большим объёмом воды)	0,6 г/сут в 4 приёма	20 мг/кг/сут в 3 приёма

[1] С осторожностью при подозрении на инфекционный мононуклеоз. [2] При сомнениях в соблюдении пациентом назначений, ревматической лихорадке у пациента или его родственников, неблагоприятных бытовых условиях и вспышках инфекции в коллективе. [3] Доза клавулановой кислоты не должна превышать 10 мг/кг в сутки из-за риска диареи.

Текст КР и таблица 1 расходятся. Цефуроксим взрослым: в тексте 250 мг 2 раза в сутки, в таблице 1,0 г в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте 40 мг/кг в сутки, в таблице 50 мг/кг. Амоксициллин детям: в тексте 50 мг/кг в сутки в 2 приёма, не более 1000 мг в сутки, в таблице в 2–3 приёма без ограничения. Клиндамицин: в тексте взрослым 300 мг 2 раза в сутки, детям 3–12 лет 20–30 мг/кг в сутки, в таблице 0,6 г в сутки в 4 приёма и 20 мг/кг. Выбор дозы остаётся за врачом; дозы следует сверить с инструкцией в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

4.3 Парентеральная терапия

Если пациент не может или не хочет принимать препарат внутрь, антибиотик вводится парентерально до стабилизации состояния с последующим переходом на пероральный приём.

Препарат	Дети	Взрослые
Ампициллин	до 1 года 100 мг/кг/сут; 1–4 года 100–150 мг/кг/сут; от 4 лет 1–2 г/сут; в 4 введения	и дети более 40 кг: 250–500 мг каждые 6 ч
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в	90 мг/кг/сут в 3 введения	и дети старше 12 лет: 1,2 г каждые 8 ч
Ампициллин + сульбактам	до 12 лет или менее 40 кг: 150 мг/кг/сут в 3–4 введения	1,5–3 г каждые 6–8 ч
Цефазолин	1 мес — 18 лет: 25–50 мг/кг/сут (при тяжёлом течении — 100) в 3–4 введения	2,0 г каждые 8 ч
Цефтриаксон	до 12 лет: 20–80 мг/кг/сут 1 раз (более 50 кг — до 2 г/сут)	и дети старше 12 лет: 2 г 1 раз в сутки
Цефотаксим	до 12 лет: 100–150 мг/кг/сут в 2–4 введения	и дети старше 12 лет или более 50 кг: 1–2 г каждые 6–8 ч
Клиндамицин (непереносимость β-лактамов)	20–40 мг/кг/сут в 3–4 введения	0,4–0,6 г каждые 6–8 ч

4.4 Симптоматическая терапия

При лихорадке и болевом синдроме назначаются ибупрофен, парацетамол или, у пациентов старше 15 лет, ацетилсалициловая кислота; детям применяются только парацетамол и ибупрофен. Здоровым детям старше 3 месяцев жаропонижающие препараты назначаются при температуре тела выше 39,0 °C при измерении в прямой кишке или выше 38,5 °C в подмышечной впадине.

Ибупрофен: взрослым 200–400 мг, детям 7,5 мг/кг, не более 30 мг/кг в сутки. Парацетамол: взрослым 500–1000 мг, детям 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не более 60 мг/кг в сутки.

Системные кортикостероиды при боли в горле рутинно не назначаются.

Исключением являются выраженный дискомфорт и угроза асфиксии, например при инфекционном мононуклеозе. В этом случае однократно внутрь назначается #дексаметазон 0,3 или 0,6 мг/кг или #преднизолон 1 мг/кг (УУР В, УДД 1).

При выраженном болевом синдроме назначаются местные анестетики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в виде спреев, растворов и таблеток для рассасывания с учётом возраста. При стрептококковой инфекции местное лечение не заменяет системную антибактериальную терапию.

Бензидамин разрешён с 3 лет, бензокаин с хлоргексидином у детей старше 4 лет, флурбипрофен старше 12 лет, кетопрофен с 12 лет. Препараты для лечения заболеваний горла в целом применяются с 3–4 лет из-за риска ларингоспазма. «Смазывание» миндалин и механическое удаление налётов не рекомендуются.

Дополнительно, в том числе курсами в межрецидивный период, возможно применение растительных препаратов: корня алтея, ромашки, тысячелистника, коры дуба, хвоща, листьев грецкого ореха, одуванчика.

Показано ограничение раздражающей пищи (острой, кислой, солёной, горячей и холодной); пища должна иметь мягкую консистенцию.

При неосложнённом тонзиллофарингите хирургическое лечение не рекомендуется.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации. Осложнения

разделы 5–7 текста КР

После тесного бытового контакта с больным стрептококковой инфекцией антибиотикопрофилактика показана беременным со сроком гестации 37 недель и более, новорождённым и родильницам в первые 28 дней, а также лицам в возрасте 75 лет и старше.

Больные стрептококковым тонзиллофарингитом подлежат изоляции от организованных коллективов, их контакты ограничиваются.

При рецидивирующем тонзиллофарингите для профилактики рецидивов назначаются лизаты бактерий.

При рецидивирующем тонзиллофарингите применяются биологически активные добавки (БАД), содержащие естественные бактерии ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

После стрептококкового тонзиллофарингита пациент находится под наблюдением в течение месяца: общий анализ крови и мочи выполняется через 7–10 дней и через 3 недели, при жалобах со стороны сердца показана электрокардиография (ЭКГ).

Лечение, как правило, проводится амбулаторно. На фоне антибактериальной терапии улучшение наступает через 12–24 часа. Ребёнок допускается в детский коллектив после полного выздоровления.

Госпитализации в инфекционное отделение подлежат пациенты в тяжёлом состоянии, а также пациенты, которым в связи с отказом от еды и питья необходима инфузионная терапия. При подозрении на гнойное осложнение, атипичной клинической картине или необходимости хирургического вмешательства показаны консультация оториноларинголога и госпитализация в хирургическое отделение.

Стрептококковая инфекция может приводить к гнойным осложнениям (паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцессы, гнойный лимфаденит) и негнойным осложнениям: острой ревматической лихорадке, ревматической болезни сердца, постстрептококковому гломерулонефриту, стрептококковому токсическому шоку, PANDAS.

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит)»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 31.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	`306_3` · открыть текст КР ↗
Разработчики	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням;

	Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Дозы цефуроксима, амоксициллина, амоксициллина с клавулановой кислотой и клиндамицина в тексте и в таблице 1 различаются; расхождения приведены в блоке «Текст КР и таблица 1 расходятся» на вкладке «Лечение».
- В таблице 1 у бензатина бензилпенициллина в колонке «Дети» указано «у пациентов старше 12 лет при m<27 кг 600 тыс. ед»; по смыслу это дозировка по массе тела, как в тексте КР.
- Таблицы доз в PDF извлекаются с нарушением порядка строк, поэтому все строки сверены по изображениям страниц 19–21.